安全性向上を目的とした無菌的分割製剤運用の改善

－臨床ニーズへの対応－

◎杢屋 拓海[1)]、岡本 拓真[1)]、鈴木 健太[1)]、中島 裕美[1)]、古川 沙也加[1)]、大石 洋美[1)]、宮崎 恵子[1)]、直田 健太郎[1)]
聖隷浜松病院 臨床検査部[1)]

【背景】1回輸血量の少ない新生児では、血液製剤の有効活用と安全性確保が課題である。令和8年2月発行の「輸血療法実践ガイド」では血液製剤の院内分割が有用であることが明記され、令和8年度診療報酬改定では無菌的分割製剤作成加算が新設された。当院では2012年度より血液製剤（RBC、PC、FFP）の無菌分割を実施しており、これまでに複数ドナーからの曝露機会の低減や廃棄血削減に取り組んできた。

【目的】臨床ニーズに応じた無菌的分割製剤の運用改善の取り組みとその有用性について報告する。

【取り組み】①NICUでは、従来3〜4分割した血液製剤を病棟で複数回シリンジ分割していたが、バッグ汚染による感染リスクやPDA認証未実施下での誤投与リスクが懸念されていた。そこで分割可能な最小容量を検討し、2021年11月より分割数をRBC2単位は10分割、PC10単位は8分割に固定して依頼分割数を統一した。これにより、1バッグあたりシリンジ分割1回で投与する運用へ変更した。
②ICUでは、ルート感染が疑われた患児の症例を契機に、輸血バッグからの感染対策としてシリンジ分割を廃止したいとの要望を受けた。そこでICU看護師と運用検討を行い、2024年12月より分割製剤の使用をICU患児へ拡大した。さらにRBCやPCに加えてFFPを持続投与する症例が多いため、融解後24時間以内かつ1バッグ6時間以内投与の制限を踏まえ、4分割対応とした。

【成果】分割製剤のPDA認証を可能としたことで、看護師からは確認作業や輸血管理の負担が軽減され、誤投与リスク低減につながったと好意的な意見が得られた。また、バッグ汚染による感染症例も発生していない。2025年度の分割依頼件数は149件（前年度85件）と増加し、本取り組みが臨床現場で高く評価されたことが示唆される。

【結語】臨床ニーズに応じた無菌的分割製剤の運用改善は感染リスク低減と新生児輸血の安全性向上に寄与したと考えられる。今後も臨床現場と連携し、安全な輸血医療の実現に努めたい。　連絡先：053-474-2632